

(U0C9M-A0L1A-GDP) GUÍA DE PERGUNTAS: O que é Saúde? Modelo Biomédico vs Modelo Ampliao

Érik Luis Mendonça Botechia de Jesus Leite¹

¹ESTUDANTE DE MEDICINA AUTOR DESTE PORTFÓLIO-COGNITIVO DE APRENDIZADO

IDENTIFICAÇÃO:

GUÍA DE PERGUNTAS: O QUE É SAÚDE? MODELO BIOMÉDICO vs MODELO AMPLIADO (U0C9M-A0L1A-GDP):

TAG: GDP

TIPO: GUÍA DE PERGUNTAS

UC: U0C9M - SAÚDE, SOCIEDADE, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

TÍTULO: O QUE É SAÚDE? MODELO BIOMÉDICO vs MODELO AMPLIADO

ORDEM: 1

EIXO: INM – INOVAÇÕES EM MEDICINA

REFERÊNCIA GLOBAL: PORTFOLIO-COGNITIVO-MEDICINA

Autor: ELBotechia

Nome Cível: Érika Luísa Mendonça Botechia de Jesus Leite

Nome Social: Érik Luis Mendonça Botechia de Jesus Leite

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5560-554X>

E-MAIL INSTITUCIONAL: 12526118413@Ulife.com.br

E-MAIL PESSOAL: elbotechia@gmail.com

CONTEÚDO PROGRESSIVO:

Bloco 1 – Conceito de Saúde

1. Explique por que o conceito de saúde não é fixo nem universal. Que fatores históricos e sociais influenciam sua definição?

Quando a saúde é vista como um processo a prioridade foca na continuidade do cuidado e a real capacidade de adesão ao plano terapêutico individual e integrado as necessidades do paciente individualizado o que resulta no sucesso por obtenção de desfechos sustentáveis e redução dos riscos na comunidade, isso se dá por meio de fatores históricos e sociais influenciarem no estado de saúde integral do ser humano e variar suas condições de saúde e doença, fatores históricos e sociais que podem influenciar são tais como: classe social, dieta, condições de vivenda como água encanada, esgoto, luz, etnia entre outros.

2. Compare as seguintes concepções de saúde:

- ausência de doença
- estado de completo bem-estar
- processo biopsicossocial

Saúde como:	
Ausência de Doença	Tem como prioridade o diagnóstico, prescrição e controle de parâmetros e seu sucesso é a normalização da doença e exames
Estado de Completo Bem-Estar	“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.” inclui aspectos físicos-biológicos, mentais e sociais
Processo Biopsicossocial	Tem como prioridade a continuidade do cuidado e a real capacidade de adesão ao plano terapêutico e o sucesso na obtenção de desfechos sustentáveis e redução dos riscos na comunidade

Quais são os limites de cada uma?

Limites de Cada definição:	
Ausência de Doença	Não prevê a integralidade do homem em seu contexto somente enxerga a doença per se
Estado de Completo Bem-Estar	Sobrecarrega ao médico ao não implementar uma equipe interdisciplinar para cuidado integral ao paciente
Processo Biopsicossocial	Barreiras culturais de implantação associadas a hierarquia enraizada no sistema de saúde e resultados que dependem de um acompanhamento mais prolongado do paciente

3. Por que a definição clássica da OMS (1946) é considerada avançada para sua época e, ao mesmo tempo, limitada na prática clínica?

“saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença”

A definição da OMS foi revolucionária porque colocou bem-estar físico mental e social como meta, mas é limitada na prática porque expressa um ideal difícil de traduzir em ações específicas de saúde, exigindo que modelos assistenciais e bioética completem esse conceito com critérios mais operacionais, cabe ressaltar como limitações:

Os questionamentos de ideias:

- O conceito de “bem-estar completo” representa um ideal difícil de ser alcançado pela maioria das pessoas
- A saúde é vista como um estado perfeito e constante
- Pequenos desconfortos podem ser considerados como indicativos de “falta de saúde”

O risco de medicalização da vida constante:

- Dificuldades diárias frequentemente são transformadas em questões médicas
- Sentimentos como tristeza, fadiga e estresse podem ser classificados como patologias
- Crescimento exagerado da intervenção médica nas esferas sociais

A desconsideração de Desigualdades Sociais como:

- Pessoas em situação de pobreza dificilmente alcançam um “bem-estar pleno”
- A definição não contempla aspectos como:
 - Renda
 - localização geográfica
 - acesso a serviços básicos
- Isso pode levar a comparações inadequadas entre contextos diferentes

Bloco 2 – Modelo Biomédico

4. Defina o modelo biomédico de atenção à saúde e descreva seus principais pressupostos.

Segundo seus Pressupostos Fundamentais:

- A origem da doença está essencialmente no organismo
- Cada enfermidade possui um mecanismo biológico particular
- Detectar a causa → Aplicar Intervenção Técnica → Resolver o Problema
- Aspectos sociais e contextuais são considerados secundários no processo diagnóstico

5. Em quais situações clínicas o modelo biomédico funciona de forma extremamente eficaz? Justifique com exemplos.

Doenças Agudas	• infecções bacterianas • episódios inflamatórios
Casos de urgência e emergência	• sepse • infarto agudo do miocárdio • acidente vascular cerebral (AVC)

6. Quais são os principais limites do modelo biomédico frente às doenças crônicas? Ao ter os aspectos sociais e contextuais considerados como **secundários** no processo de diagnóstico.

Não prevê a pessoa em sua integralidade frente a doença de modo que está, está essencialmente no organismo, desconsiderando fatores sociais e ambientais que no caso das doenças crônicas são importantes para sua evolução diagnóstica.

7. Explique por que o modelo biomédico tende a individualizar o adoecimento.

Segundo seus Princípios

- Tem Fundamentação científica robusta, apoiada em bases fisiopatológicas
- Tem Grande eficiência na intervenção ágil e efetiva
- Seu Foco é na evidência, nos protocolos e no uso da tecnologia

Deste modo seu foco está no achado de sintomas e emissão de protocolos evidenciando a doença como um mecanismo biológico particular.

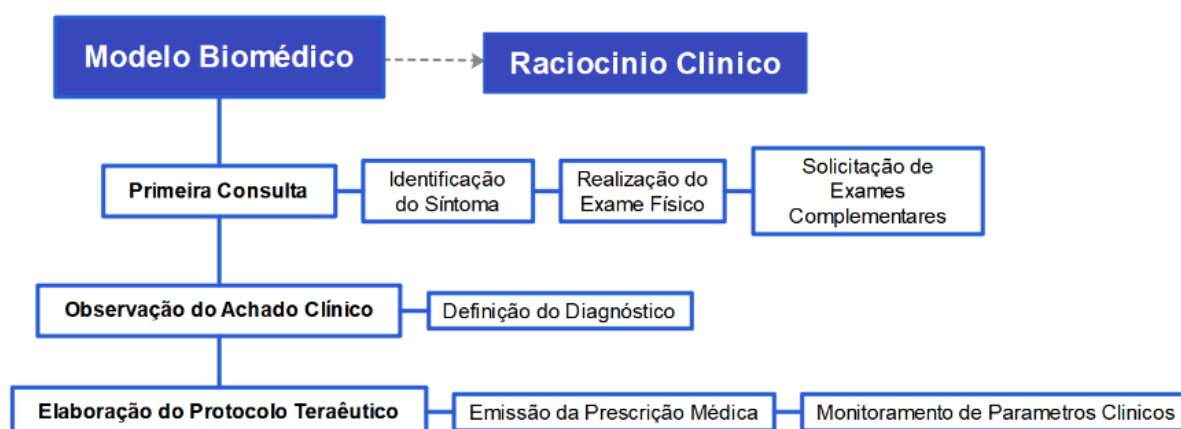
Bloco 3 – Caso Clínico (Aplicação)

Considere o caso discutido em aula:

Dois pacientes com hipertensão arterial, mesmo diagnóstico, mesma medicação na UBS. Um controla a pressão; o outro retorna descompensado e interna

8. Quais explicações o modelo biomédico oferece para esse desfecho diferente?

O raciocínio clínico do modelo biomédico, tem a analogia do corpo como máquina, de modo que:



Neste raciocínio clínico se ausentam os fatores históricos, sociais e ambientais de contexto do

paciente, deste modo o descontrole em um dos pacientes é resultado destes fatores que não são levados em conta em este modelo.

Cabe ressaltar que o peso negativo deste modelo cai sobre o paciente que é responsabilizado pelo descontrole pelo "não cumprimento à risca" do solicitado pela figura do médico.

9. Quais aspectos do caso o modelo biomédico não consegue explicar adequadamente?

Neste raciocínio clínico se ausentam os fatores históricos, sociais e ambientais de contexto do paciente, deste modo o descontrole em um dos pacientes é resultado destes fatores que não são levados em conta em este modelo.

10. Por que atribuir o descontrole apenas à "não adesão" pode ser uma análise insuficiente?

Ao não realizar uma anamnese de história de vida prévia do paciente e seus hábitos e contextos e ao não possuir uma equipe interdisciplinar que auxilie na conscientização de mudança de hábitos e cuidados de outros parâmetros importantes para uma doença crônica no contexto de um paciente "não controlado e não conscientizado" o fracasso do tratamento é eminente.

Bloco 4 – Modelo Ampliado de Saúde

11. Explique o que significa afirmar que saúde é um fenômeno biopsicossocial.

Afirmar que a saúde é um fenômeno biopsicossocial é adotar uma visão holística e integrada, desde os aspectos biológicos, físicos, psicológicos e sociais que corresponde ao modelo ampliado de saúde deste modo integrando medicina, psicologia e ciências sociais e outros profissionais da saúde na compreensão e no cuidado com a pessoa envolvendo uma equipe interdisciplinar no cuidado do indivíduo e adesão de um projeto terapêutico individual (PTI) para o cuidado de cada paciente considerando seu contexto atual.

12. Diferencie "comportamento individual" de "condição estrutural" no processo saúde-doença.

Comportamento Individual	Condição Estrutural
São os comportamentos resultados dos hábitos de vida individualizados do paciente em seu contexto em que não se considera um estado de vulnerabilidade ou desigualdade social que produzem estes comportamentos	São hábitos e comportamentos resultantes de condições de desigualdade social e vulnerabilidade

13. Dê três exemplos de determinantes sociais que podem interferir no controle da hipertensão.

- Dieta
- Condições de Trabalho
- Sedentarismo